

工作單 A | 概念整合工作單

情緒焦點治療督導的基礎：理論、原則與督導者角色（對應 Greenberg & Tomescu, 2017，叢書序 + 第1章）

預估時間：35–45 分鐘 | 使用時機：課前預習後或課後複習

姓名

日期

督導／教師

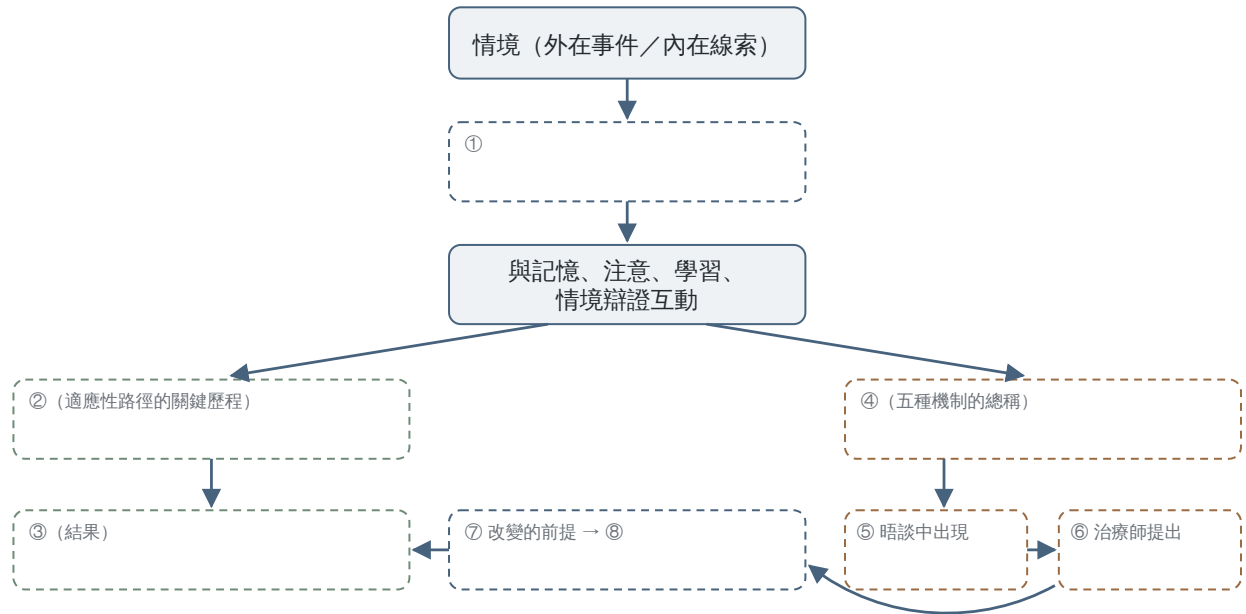
本工作單對應的學習目標

1. 能說明辯證建構主義如何解釋「情緒被建構而成為意識感受」，並據此說明 EFT 為何以「功能不良的處理風格」取代「精神病理」來理解個案。
2. 能區分原發適應性、原發非適應性、次發反應性與工具性情緒；在一段假想個案陳述中運用四項情緒評估準則判斷其類型，並選擇相應的處理方向。
3. 能以六大 EFT 原則分析一段督導或晤談片段，指出哪些回應體現了「跟隨與引導」、「歷程診斷」與「知覺技能」，哪些違反了這些原則。

使用說明：先不看講義，用自己的話完成各部分；完成後再對照原文與講義，用另一種顏色的筆補充或修正。這是讓概念結構成為你自己的工具，不是測驗。

Part 1 | 概念地圖：情緒如何被處理，又如何走向改變

請在空白框中填入適當的概念。提示詞庫（可重複使用，也可以不用）：符號化／情緒基模被激發／標記／任務／功能不良的處理風格／新意義與自我強化／接納（抵達）／體感／適應性行動



節點	我填入的概念	一句話說明（用自己的話）
①		

②		
③		
④		列出五種機制：
⑤ ⑥		
⑦ ⑧		

用 2–3 句話說明：為什麼在這張圖裡，治療師的「措辭」本身就會影響個案感受到什麼？

Part 2 | 區辨比較表：四種情緒類型

「最容易混淆的是」請填入另一種情緒類型，並說明混淆的原因。「如何區分」請寫出可觀察的線索，並註明使用了哪一項評估準則（①非語言、②普世反應、③治療師自身反應、④個案特徵模式）。

類型	定義（用自己的話）	臨床上看起來像……	最容易混淆的是……	如何區分（線索 + 準則）	處理方向
原發適應性					
原發非適應性					
次發反應性					

工具性					
-----	--	--	--	--	--

同一個「憤怒」可以分別屬於四種類型。請各用一句話寫出一個簡短的假想情境：

類型	憤怒出現的情境（一句話）
原發適應性憤怒	
原發非適應性憤怒	
次發反應性憤怒	
工具性憤怒	

Part 3 | 六大原則：在治療中 vs. 在督導中

原則	在治療中，治療師會……	在督導中，督導者會……
① 跟隨與引導		
② 同理探索回應風格		
③ 歷程診斷而非人的診斷		
④ 促進更深的情緒經驗		
⑤ 學習與教導知覺技能		

⑥ 情緒與需求跨越文化		
-------------	--	--

原教材說 EFT 的「失功能理論」與「治療理論」不直接套用到督導上。這條界線的具體意思是什麼？如果越過它，會發生什麼？

Part 4 | 「原文說法 → 我的臨床理解」轉譯

原文說法（精確意譯）	我的臨床理解：在晤談或督導中，這代表我會怎麼做？
「個案必須先抵達一個地方，才能離開那個地方。」（p. 6）	
「知覺技能……涉及知道何時介入，而非如何介入。」（p. 11）	
「督導的一部分藝術，在於以讓人感受為支持、而非批評的方式給予矯正性回饋。」（p. 19）	
「個案不被視為經驗著精神病理，而是擁有一種功能不良的情緒處理風格。」（p. 6）	

Part 5 | 誤解修正：對／錯／視情況而定

#	陳述	判斷	理由（引用本單元概念）
1	悲傷一定比憤怒更「深」，所以憤怒底下一定有悲傷。	對／錯／視情況	
2	工具性情緒就是操弄，治療師應該設界限，不予回應。	對／錯／視情況	

3	EFT 採歷程診斷，所以 EFT 治療師不需要評估自殺風險。	對／錯／視情況	
4	督導者最好不要給矯正性回饋，以免破壞督導同盟。	對／錯／視情況	
5	受督者在督導中提到個人困擾時，督導者可以提供支持性諮商。	對／錯／視情況	
6	集體主義文化的個案對父母沒有憤怒，因此不需要探索。	對／錯／視情況	
7	EFT 的介入步驟是「可以做」的建議，所以沒有好壞之分。	對／錯／視情況	
8	讀懂理論之後，只要累積臨床時數，自然就能在晤談中辨認標記。	對／錯／視情況	

Part 6 | 提取練習（先憑記憶作答，再核對原文）

#	問題	憑記憶作答	核對後 ✓ / 補充
1	情緒評估的四項準則是哪四項？		
2	任務的五大類別是什麼？		
3	Bernard 的三種督導者角色是什麼？EFT 如何限制「諮商者」角色？		
4	EFT 從個人中心、完形、存在治療各吸收了什麼？		
5	什麼是「一致」的督導事件？舉原書的一個例子。		

自我評估

學習目標	我的把握程度 (1 = 很沒把握, 5 = 很有把握)
1. 說明辯證建構主義與功能不良處理風格	① ② ③ ④ ⑤
2. 區分四種情緒類型並運用四項評估準則	① ② ③ ④ ⑤
3. 以六大原則分析晤談或督導片段	① ② ③ ④ ⑤

我目前最不確定的是……

反思

1. 本單元哪一個概念，最挑戰你原本對「治療師該做什麼」的想法？為什麼？

2. 在四種情緒類型中，哪一種是你在自己或身邊的人身上最難辨認的？你猜為什麼？（自願分享）

督導／教師回饋欄